



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 22 — Hemorragia Digestiva Alta (varicosa e não varicosa) — e notas sobre hemorragia digestiva baixa

Reconhecimento, ressuscitação restritiva, Glasgow-Blatchford, IBP e vasoativo, antibiótico no cirrótico, anticoagulantes, tempo da endoscopia e transferência — cenário: pronto-socorro sem endoscopia e sem UTI

Código	PS-ND-22	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A HDA tem mortalidade de 5–10% (não varicosa) a 15–20% (varicosa) e é uma doença de **primeiras 24 horas**: a maioria das mortes ocorre por ressuscitação inadequada, transfusão excessiva, atraso no vasoativo/antibiótico no cirrótico e endoscopia tardia. O PS Natal Diegues não tem endoscopia: o que ele faz é **estratificar (quem pode ir para casa), ressuscitar com sangue e não com litros de cristalóide, iniciar os fármacos certos em ≤1 h e transferir para o serviço com endoscopia em ≤12–24 h** (ou em horas, se instável).

Fontes de ancoragem: Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, et al. **ACG Clinical Guideline: upper gastrointestinal and ulcer bleeding**. Am J Gastroenterol 2021;116:899 [ACG 2021]; Gralnek IM, et al. **Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper GI hemorrhage: ESGE Guideline — update 2021**. Endoscopy 2021;53:300 [ESGE 2021]; Barkun AN, et al. International consensus (ICON-UGIB). Ann Intern Med 2019;171:805; **de Franchis R, et al. Baveno VII — Renewing consensus in portal hypertension**. J Hepatol 2022;76:959 [BAVENO VII]; Kaplan DE, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. Hepatology 2024;79:1180 [AASLD 2024]; Gralnek IM, et al. ESGE guideline on variceal bleeding, 2022. Endoscopy 2022;54:1094; Villanueva C, et al. Transfusion strategies for acute upper GI bleeding. N Engl J Med 2013;368:11; Stanley AJ, et al. Comparison of risk scoring systems (Glasgow-Blatchford). BMJ 2017;356:i6432; Sociedade Brasileira de Hepatologia / SOBED — recomendações nacionais (edição vigente) [SBH/SOBED — VERIFICAR]; Oakland K, et al. BSG guideline on acute lower GI bleeding. Gut 2019;68:776 [BSG-HDB 2019].

Convenção de confiança: doses seguem ACG/ESGE 2021 e Baveno VII; **[VERIFICAR]**: qual hospital de referência tem endoscopia 24 h (Tabajara Ramos x Santa Casa), terlipressina/octreotida no estoque, IBP IV, eritromicina IV, balão de Sengstaken-Blakemore, tipagem/hemocorrelatos (hemocentro), CCP para reversão.

1. Queixa — como o paciente chega

"Vomitei sangue" (hematêmese — vermelho vivo ou "borra de café"), "fezes pretas, grudentas e fedorentas" (melena — 90% é HDA), "sangue vivo pelo ânus" (hematoquezia — HDB, mas HDA maciça em 10–15%), "tontura, fraqueza, desmaiei", "suando frio"; síncope + melena = sangramento significativo. Perguntar: quantidade e tempo (episódios),

AINE/AAS/anticoagulante/antiagregante, álcool, cirrose conhecida (varizes, ligadura prévia, betabloqueador), úlcera/*H. pylori* prévios, vômitos antes do sangue (Mallory-Weiss), dor epigástrica, emagrecimento/disfagia (neoplasia), cirurgia aórtica (fístula aortoentérica), coagulopatia, DRC, cardiopatia (limiar transfusional), última refeição.

Causas

Não varicosa (~80%)	Varicosa (~10–20%; 50% em cirróticos)	Simuladores
Úlcera péptica (gástrica/duodenal — 40–50%; AINE, <i>H. pylori</i> , estresse), erosões (gastrite/esofagite), Mallory-Weiss , angiodisplasia, lesão de Dieulafoy, neoplasia, esofagite, fístula aortoentérica, hemobilia	Varizes esofágicas/gástricas, gastropatia hipertensiva portal — cirrose (álcool, hepatite B/C, esteato-hepatite), esquistossomose (frequente na região sem cirrose), trombose de porta	Epistaxe deglutida, hemoptise, alimentos (beterraba, ferro, bismuto → fezes escuras sem sangue oculto), sangramento oral

2. Clínica — gravidade, estratificação e decisão de local

2.1 Sinais de gravidade (qualquer um = ressuscitar e transferir com urgência)

- Choque/hipoperfusão: PAS <90–100, FC >100–120, hipotensão ortostática (queda PAS ≥20 ou FC ↑ ≥20 ao sentar/levantar — perda ≥15–20%), TEC >3 s, sudorese, confusão, oligúria.
- Hematêmese vermelha volumosa ou hematoquezia com instabilidade; sangramento persistente na sonda/observação; síncope.
- Hb <7–8 g/dL na chegada (pode estar falsamente normal nas primeiras horas), ureia/creatinina >100 (sangue digerido), INR >1,5, plaquetas <50.000.
- Cirrose/suspeita de varizes, idade >60, cardiopatia/DRC/hepatopatia, anticoagulação, sangramento em internado.

2.2 Escore de Glasgow-Blatchford (GBS) — antes da endoscopia [ACG/ESGE 2021: GBS 0–1 → alta com endoscopia ambulatorial]

Variável	Pontos	Variável	Pontos
Ureia (mg/dL): 39–48 / 48–60 / 60–75 / ≥75	2 / 3 / 4 / 6	Hb homem: 12–13 / 10–12 / <10	1 / 3 / 6
Hb mulher: 10–12 / <10	1 / 6	PAS: 100–109 / 90–99 / <90	1 / 2 / 3
FC ≥100	1	Melena / síncope	1 / 2
Hepatopatia / IC	2 / 2	Total 0–23	0–1: baixo risco (<1% de intervenção) → alta; ≥7: alto risco de precisar de endoscopia terapêutica; ≥12: muito alto

Critérios de alta com GBS 0–1 (ACG 2021): ureia <39, Hb ≥13 (H)/≥12 (M), PAS ≥110, FC <100, sem melena/síncope/hepatopatia/IC, com acesso a endoscopia ambulatorial em ≤7 dias, sem anticoagulante, com acompanhante. Rockall e AIMS65 são alternativas para prognóstico; o GBS é o melhor para decidir alta.

2.3 HDA varicosa — suspeitar e tratar como tal quando

Cirrose conhecida ou estigmas (aranhas vasculares, eritema palmar, ginecomastia, ascite, circulação colateral, icterícia, encefalopatia, esplenomegalia), etilismo, hepatite B/C, esquistossomose, plaquetopenia + INR alto, varizes/ligadura prévias, hematêmese volumosa sem dor. **Na dúvida, dar vasoativo + antibiótico**: o custo de tratar uma não varicosa como varicosa é pequeno; o inverso mata.

2.4 Hemorragia digestiva baixa — notas [BSG-HDB 2019]

Hematoquezia em paciente estável: diverticular (mais comum), angiodisplasia, hemorroidas/fissura, colite (isquêmica, infecciosa, DII), pós-polipectomia, neoplasia. **Hematoquezia com instabilidade = HDA até prova em contrário** (endoscopia alta primeiro). Escore de Oakland ≤ 8 → manejo ambulatorial; instável → ressuscitar + angio-TC (referência); colonoscopia após preparo em 24 h; a maioria cessa espontaneamente. Anuscopia no PS se sangramento vermelho vivo pequeno e estável (hemorroidas/fissura).

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / conduta
Sinais vitais + ortostáticos + TEC + sensorio	Definem choque e classe de hemorragia (ATLS): I <15% (FC normal); II 15–30% (FC >100, PA normal, ortostase); III 30–40% (PAS ↓, confusão); IV >40% (choque profundo)
Estigmas de hepatopatia	Aranhas, eritema palmar, ginecomastia, ascite, esplenomegalia, icterícia, flapping, circulação colateral → varicosa
Abdome	Dor/defesa (perfuração — não é HDA típica; RX/TC), massa, hepatomegalia, ascite
Toque retal	Melena × hematoquezia × fezes normais (escurecimento por ferro/bismuto não tem cheiro característico nem é grudento); massa retal; hemorroidas
Pele e mucosas	Palidez, petéquias/equimoses (coagulopatia), telangiectasias (Osler-Weber-Rendu), sinais de desnutrição/etilismo
Nariz e orofaringe	Epistaxe/lesão oral deglutida (simulador)
Sonda nasogástrica	Não é obrigatória (ESGE/ACG: não recomendada de rotina); lavado com sangue confirma HDA ativa, mas lavado limpo não exclui (duodenal); útil se dúvida entre alta/baixa e para esvaziar antes da endoscopia — não retarda a transferência

4. Propedêutica armada

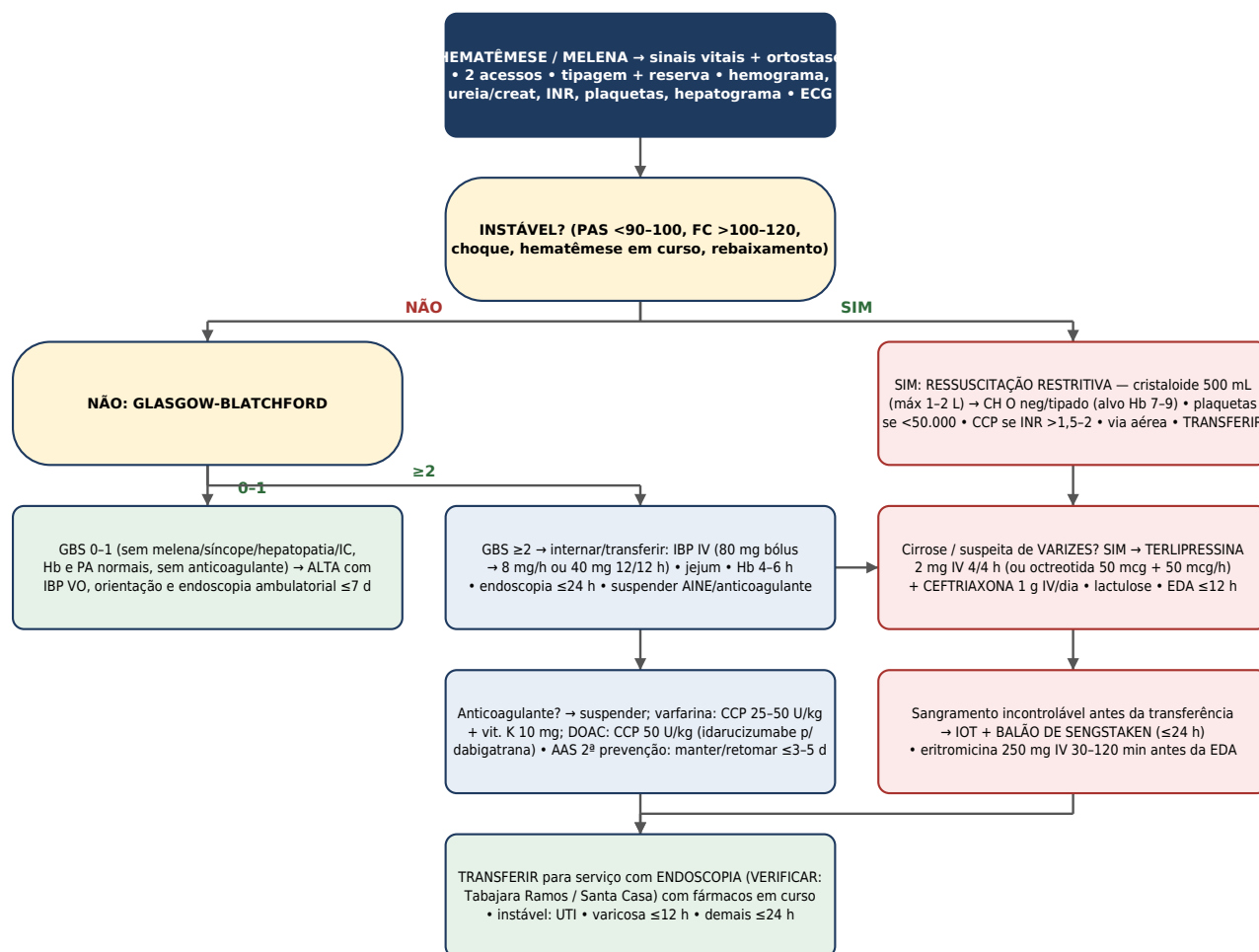
Exame	Para que serve	Quando
Hemograma	Hb/Ht (repetir a cada 4–6 h; a queda aparece após hemodiluição), plaquetas	Chegada; seriado
Tipagem sanguínea + prova cruzada (reserva de 2–4 CH)	Transfusão; O negativo se instável sem tempo	Chegada — todos com sinais de gravidade
Ureia/creatinina	Ureia desproporcional (relação ureia/creatinina >100 ou BUN/creat >30) sugere HDA; GBS; função renal	Chegada
TAP/INR, TTPa, fibrinogênio	Coagulopatia (cirrose, anticoagulante), reversão	Chegada
TGO/TGP, bilirrubinas, albumina, sódio	Hepatopatia; Child-Pugh/MELD (prognóstico da varicosa)	Chegada
ECG, troponina	Isquemia por anemia/hipotensão (idoso, cardiopata) — define limiar transfusional 8	Idoso, cardiopata, dor torácica
Gasometria/lactato	Choque oculto	Instável
Glicemia, eletrólitos, cálcio (transfusão maciça)	Correções	Chegada; após transfusão
RX de tórax / abdome agudo	Perfuração (pneumoperitônio) se dor/peritonismo — muda para cirurgia	Selecionado
Endoscopia digestiva alta	Diagnóstico + terapêutica (clipe, injeção, térmico; ligadura de varizes); estratifica (Forrest)	≤ 24 h em todos os internados; ≤ 12 h na varicosa; urgente (≤ 6–12 h após ressuscitação) se instabilidade persistente, hematêmese em curso, sangue na sonda — na referência
Angio-TC / arteriografia	Sangramento ativo sem lesão à endoscopia, fístula aortoentérica, HDB instável	Referência

5. Fisiopatologia

Na **úlcera péptica**, o ácido e a pepsina erodem a mucosa protegida insuficientemente (AINE inibe prostaglandinas; *H. pylori* inflama) até atingir um vaso da submucosa — o sangramento arterial da artéria gastroduodenal (úlcera duodenal posterior) ou da gástrica esquerda pode ser maciço. O coágulo só se estabiliza em pH >6 (a pepsina o dissolve em meio ácido): por isso o IBP em dose alta, que reduz ressangramento e necessidade de cirurgia, embora não reduza mortalidade antes da endoscopia. Na **hipertensão portal**, a resistência hepática desvia o fluxo para colaterais esofagogástricas de parede fina que rompem quando o gradiente porto-sistêmico excede 12 mmHg; a vasodilatação esplâncnica sustenta o fluxo — a **terlipressina/octreotida** reduzem esse fluxo e o gradiente. O cirrótico sangrando tem translocação bacteriana e 20-50% de infecção (PBE, pneumonia, ITU): o **antibiótico profilático reduz ressangramento e mortalidade**. A **transfusão liberal** eleva a pressão portal e aumenta ressangramento e morte (Villanueva 2013) — daí o limiar de Hb 7 (8 em cardiopata) e a ressuscitação com o mínimo de cristalóide. A ureia sobe pela absorção do sangue digerido (proteína) — marcador de HDA e do GBS. A **eritromicina IV** esvazia o estômago por ação procinética (agonista da motilina), melhorando a visão endoscópica e reduzindo a necessidade de segunda endoscopia.

6. Fluxo de atendimento [ACG/ESGE 2021; Baveno VII, adaptado ao PS sem endoscopia]

Ordem: **estabilizar com sangue, não com litros** → **estratificar (GBS)** → **IBP a todos os internados**; **vasoativo + antibiótico ao cirrótico em ≤1 h** → **reverter anticoagulante se necessário** → **transferir para endoscopia no tempo certo**.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → 2 acessos, tipagem, hemograma/INR/ureia	≤15 min
Instável → 1ª unidade de CH (O negativo se sem tipagem)	≤30 min
Chegada → IBP IV (internados)	≤1 h
Suspeita varicosa → terlipressina/octreotida + ceftriaxona	≤1 h (antes da endoscopia)
Anticoagulado com sangramento grave → reversão	≤1 h
Regulação para endoscopia	Ao classificar: instável → imediata (endoscopia ≤6-12 h após ressuscitação); varicosa ≤12 h; demais ≤24 h
Hb de controle	A cada 4-6 h nas primeiras 24 h

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Ressuscitação e transfusão [ACG/ESGE 2021; Villanueva 2013; Baveno VII]

Item	Conduta
Acessos e monitor	2 jectos 14–16G (ou intraóssea); monitor, PA a cada 5–15 min, diurese (sonda se choque)
Cristaloide	Restritivo: bólus de 500 mL (Ringer/SF) até obter sangue; evitar >1–2 L (hemodiluição, ↑ pressão portal, coagulopatia dilucional); alvo PAS 90–100 no varicoso até o controle (hipotensão permissiva relativa)
Concentrado de hemácias	Hb <7 g/dL → transfundir (alvo 7–9); Hb <8 se cardiopatia isquêmica/idoso instável; sangramento maciço/choque: transfundir antes do resultado (O negativo/tipado); 1 CH ↑ Hb ~1 g/dL; aquecer se maciça
Plaquetas	<50.000 com sangramento ativo: 1 U/10 kg (ou 1 aférese)
Plasma fresco / CCP / fibrinogênio	INR >1,5–2 com sangramento ativo: PFC 15 mL/kg ou CCP 25–50 U/kg (mais rápido, menos volume — preferir no anticoagulado); fibrinogênio <100–150: crioprecipitado 1 U/10 kg. Cirrótico: não corrigir INR de rotina (não prediz sangramento; PFC ↑ pressão portal) — Baveno VII
Transfusão maciça (≥4 CH em 1 h / ≥10 em 24 h)	Proporção 1:1:1 (CH:PFC:plaquetas), cálcio (gluconato 10% 10 mL a cada 4 CH), aquecimento, ácido tranexâmico não (HALT-IT: sem benefício, ↑ trombose)
Via aérea	IOT precoce se hematêmese maciça, rebaixamento, encefalopatia (proteção contra aspiração); sequência rápida com cautela hemodinâmica (cetamina); aspirar
Posição	Decúbito lateral se vômitos; cabeça elevada se protegida

7.2 Fármacos — HDA não varicosa [ACG/ESGE 2021]

Fármaco	Dose	Observações
Inibidor de bomba de prótons IV	Omeprazol/pantoprazol/esomeprazo I 80 mg IV em bólus → 8 mg/h em infusão contínua por 72 h (após endoscopia com estigma de alto risco) ou 40 mg IV 12/12 h (dose intermitente é equivalente — ESGE); pré-endoscopia: 80 mg bólus + 40 mg 12/12 h	Reduz estigmas de alto risco e necessidade de terapia endoscópica; não substitui nem atrasa a endoscopia; VO 40 mg 12/12 h após 72 h; baixo risco (GBS 0–1): VO desde o início
Eritromicina IV	250 mg IV em 30 min, 30–120 min antes da endoscopia	Esvazia o estômago; ↓ necessidade de 2ª endoscopia; QT longo — ECG; [VERIFICAR disponibilidade — dar no PS se a transferência for direta para a EDA]
Ácido tranexâmico	—	Não recomendado (HALT-IT 2020)
Somatostatina/octreotida na não varicosa	—	Sem benefício de rotina; opção se sangramento incontrolável aguardando endoscopia
<i>H. pylori</i>	Testar (biópsia/urease/sorologia) e erradicar após — ambulatorial	Reduz recorrência de úlcera
Após endoscopia (referência)	Forrest Ia/Ib/IIa/IIb → terapia endoscópica + IBP 72 h; IIc/III → VO e alta precoce	—

7.3 Fármacos — HDA varicosa / cirrótico [Baveno VII; AASLD 2024; ESGE 2022]

Fármaco	Dose	Observações
Terlipressina (1ª escolha no Brasil)	2 mg IV em bólus lento a cada 4 h (1 mg se <50 kg) nas primeiras 48 h; depois 1 mg 4/4 h; total 2-5 dias	Iniciar na suspeita, antes da endoscopia; ↓ mortalidade; efeitos: isquemia (coronariana, mesentérica, digital), hiponatremia, bradicardia — ECG, cautela em cardiopata/>70 anos; [VERIFICAR estoque]
Octreotida (alternativa)	50 mcg IV bólus → 50 mcg/h por 2-5 dias	Menos efeitos adversos; eficácia semelhante para controle; somatostatina 250 mcg bólus → 250 mcg/h
Antibiótico profilático	Ceftriaxona 1 g IV 1×/dia por 7 dias (máx.); alternativa: norfloxacin 400 mg VO 12/12 h (se resistência local baixa)	Todo cirrótico com HDA , independentemente de ascite; ↓ infecção, ressangramento e morte; iniciar em ≤1 h
Lactulose	20-30 mL VO/SNG 8/8 h (alvo 2-3 evacuações) ou enema	Prevenção/tratamento de encefalopatia hepática
Betabloqueador	Suspender durante o sangramento; reiniciar (propranolol/carvedilol) após controle e antes da alta na referência	Profilaxia secundária + ligadura
Ligadura elástica	Endoscopia ≤12 h; ligadura (varizes esofágicas) ou cianoacrilato (gástricas)	Referência; TIPS precoce (≤72 h) em Child B com sangramento ativo/Child C ≤13 — centro terciário
Balão de Sengstaken-Blakemore	Só com IOT: balão gástrico 250-300 mL de ar (confirmar posição), tração 0,5-1 kg; esofágico 30-40 mmHg apenas se persistir; máx. 24 h ; desinsuflar esofágico 5 min a cada 6 h	Ponte para transferência em sangramento incontrolável; stent esofágico autoexpansível é alternativa na referência; complicações: necrose, ruptura, aspiração [VERIFICAR balão no PS]
Evitar	PFC para corrigir INR; volume excessivo; transfusão para Hb >9; sedação profunda sem via aérea; AINE	—

7.4 Anticoagulantes e antiagregantes [ACG 2021; ESGE 2021]

Situação	Conduta
Varfarina	Suspender; sangramento grave/instável: CCP 25-50 U/kg IV + vitamina K 10 mg IV lento (PFC 15 mL/kg se CCP indisponível); não atrasar a endoscopia por INR <2,5; reiniciar em 7 dias (ou antes se alto risco trombótico — prótese mecânica: ponte com heparina)
DOAC	Suspender; grave: CCP 50 U/kg (rivaroxabana/apixabana/edoxabana); idarucizumabe 5 g (dabigatрана) [VERIFICAR]; hemodiálise para dabigatрана; reiniciar em 7 dias conforme risco
AAS (prevenção secundária / stent)	Prevenção secundária : não suspender ou retomar em ≤3-5 dias (suspensão >7 dias ↑ IAM/morte); prevenção primária: suspender e não retomar; stent coronariano recente com DAPT: manter AAS, discutir P2Y12 com cardiologia em 24 h — não suspender os dois sem discussão
Clopidogrel/ticagrelor/prasugrel	Suspender temporariamente se sem stent recente; plaquetas não reverterem o efeito (não transfundir só por isso)
Heparina/HBPM	Suspender; protamina se HNF (1 mg/100 U)

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Instável, hematemese em curso, choque, transfusão maciça, IOT, balão	Imediata (ressuscitação em curso; sangue reservado)	UTI + endoscopia urgente — referência com endoscopia 24 h [VERIFICAR: Tabajara Ramos x Santa Casa]
HDA varicosa/suspeita (estável)	≤12 h (vasoativo + ATB em curso)	Endoscopia — referência
HDA não varicosa com GBS ≥2, estável	≤24 h (IBP em curso)	Endoscopia — referência (ou observação no PS se endoscopia agendada ≤24 h e Hb estável [VERIFICAR fluxo])
GBS 0-1 com critérios de alta	Alta	Endoscopia ambulatorial ≤7 dias; UBS
Perfuração/peritonite, fístula aortoentérica, sangramento incontrolável por endoscopia	Imediata	Cirurgia — Santa Casa de Mogi Guaçu / referência
HDB instável	Imediata	Endoscopia alta + angio-TC — referência

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 se instável: 2 acessos, CH em curso (com equipo de sangue), monitor, O₂, aspirador, decúbito lateral; via aérea segura se indicada; balão fixo e monitorado.
- Relatório: hora/volume do sangramento, sinais vitais seriados, Hb/INR/plaquetas/ureia seriados, GBS, **unidades transfundidas e horários**, fármacos (IBP, terlipressina/octreotida, ceftriaxona, eritromicina — dose/hora), reversão de anticoagulante, medicações de uso (AINE/anticoagulante/antiagregante e motivo), cirrose (Child), tipagem, reserva de sangue.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 Alta — pacote (GBS 0-1 ou após endoscopia na referência)

- IBP VO (omeprazol 40 mg 12/12 h por 2 semanas, depois 1x/dia por 4-8 semanas em úlcera); suspender AINE (analgesia alternativa); erradicação de *H. pylori* quando indicada; orientação de sinais de ressangramento (melena, hematemese, tontura) e retorno imediato.
- Retomada de antiagregante/anticoagulante com data escrita e discussão com cardiologia; cirrótico: betabloqueador, ligadura seriada, vacinas, abstinência de álcool, encaminhar hepatologia.
- Endoscopia ambulatorial ≤7 dias agendada antes da alta; retorno na UBS em 48-72 h com hemograma.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com sinais vitais ortostáticos, tipagem e GBS documentados na admissão	≥95%
% de transfusões com Hb pré <7 (ou <8 com justificativa cardiovascular) — transfusão com Hb ≥9 (evento)	≥90% / registrar
% de cirróticos com vasoativo + antibiótico em ≤1 h	≥90%
% de internados com IBP IV em ≤1 h	≥90%
% de anticoagulados graves com reversão em ≤1 h	≥90%
% de GBS 0-1 com alta e endoscopia ambulatorial agendada; % de GBS ≥2 transferidos/endoscopados em ≤24 h (≤12 h varicosa)	≥80% / ≥90%
Ácido tranexâmico, cristalóide >2 L antes de sangue, PFC de rotina em cirrótico (eventos)	0 / registrar
Ressangramento em 7 dias, mortalidade em 30 dias (via referência)	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
IBP contínuo x intermitente	ACG 2021: contínuo 72 h após terapia endoscópica; ESGE 2021: intermitente em dose alta é equivalente. Adotadas ambas as opções
Sonda nasogástrica	ACG/ESGE: não de rotina. Adotada como opcional diagnóstica
Tempo da endoscopia	ACG/ESGE: ≤24 h; endoscopia "urgente" (<6 h) não melhora desfecho em estável (Lau 2020) — ressuscitar primeiro; varicosa ≤12 h (Baveno). Adotado
Terlipressina x octreotida	Baveno VII: qualquer vasoativo; terlipressina reduz mortalidade em meta-análises antigas; efeitos adversos maiores. Adotada terlipressina como 1ª (disponível no Brasil) com octreotida alternativa
Correção de INR no cirrótico	Baveno VII/AASLD: não corrigir de rotina — divergente de prática antiga. Adotado
Ácido tranexâmico	HALT-IT: sem benefício e ↑ TEV — não usar (ACG/ESGE). Adotado
Limiar transfusional no cardiopata	ACG: 8; alguns: 9 em SCA ativa. Adotado 8 (9 se SCA em curso — Protocolo 01)
Referência com endoscopia 24 h	Pactuação define se o clínico com HDA vai para Tabajara Ramos ou Santa Casa — [VERIFICAR/PACTUAR] (é a decisão operacional mais importante deste protocolo)
Balão de Sengstaken, terlipressina, eritromicina IV, CCP	Disponibilidade [VERIFICAR]

10. Referências

- Laine L, Barkun AN, Saltzman JR, Martel M, Leontiadis GI. ACG Clinical Guideline: upper gastrointestinal and ulcer bleeding. *Am J Gastroenterol* 2021;116(5):899-917.
- Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): ESGE Guideline — update 2021. *Endoscopy* 2021;53(3):300-332. Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: guideline recommendations from the International Consensus Group. *Ann Intern Med* 2019;171(11):805-822.
- de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. Baveno VII — Renewing consensus in portal hypertension. *J Hepatol* 2022;76(4):959-974. Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. AASLD Practice Guidance on risk stratification and management of portal hypertension and varices in cirrhosis. *Hepatology* 2024;79(5):1180-1211. Gralnek IM, Camus Duboc M, Garcia-Pagan JC, et al. Endoscopic diagnosis and management of esophagogastric variceal hemorrhage: ESGE Guideline. *Endoscopy* 2022;54(11):1094-1120.
- Villanueva C, Colomo A, Bosch A, et al. Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. *N Engl J Med* 2013;368(1):11-21. Stanley AJ, Laine L, Dalton HR, et al. Comparison of risk scoring systems for patients presenting with upper gastrointestinal bleeding. *BMJ* 2017;356:i6432. HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding. *Lancet* 2020;395:1927-1936. Lau JYW, Yu Y, Tang RSY, et al. Timing of endoscopy for acute upper gastrointestinal bleeding. *N Engl J Med* 2020;382:1299-1308.
- Oakland K, Chadwick G, East JE, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. *Gut* 2019;68(5):776-789.
- Sociedade Brasileira de Hepatologia; Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva — recomendações nacionais para HDA varicosa e não varicosa (edição vigente) [VERIFICAR].
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de hemorragia digestiva (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração